



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM BUDAYA KESELAMATAN
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Program Kerja Budaya Keselamatan Pasien Rumah Sakit Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Program kerja ini merupakan salah satu upaya rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap proses pelayanan.

Budaya keselamatan pasien merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penerapan budaya keselamatan pasien tidak hanya berfokus pada pencegahan terjadinya insiden keselamatan pasien, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang terbuka, adil, saling mendukung, serta berorientasi pada pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh unsur rumah sakit, mulai dari manajemen, tenaga kesehatan, tenaga penunjang, hingga seluruh staf untuk membangun dan mempertahankan budaya keselamatan pasien yang kuat.

Penyusunan program kerja ini didasarkan pada hasil evaluasi dan survei budaya keselamatan pasien yang telah dilaksanakan di Rumah Sakit, sehingga kegiatan yang direncanakan diharapkan mampu menjawab kebutuhan perbaikan dan penguatan budaya keselamatan pasien secara berkesinambungan. Program kerja ini juga disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kesadaran, kepatuhan, pelaporan insiden, pembelajaran organisasi, serta pengembangan budaya kerja yang aman bagi pasien maupun petugas.

Kami menyadari bahwa program kerja ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Semoga Program Kerja Budaya Keselamatan Pasien ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan keselamatan pasien dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien di rumah sakit.

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan pasien merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan wajib menciptakan sistem yang mampu menjamin keselamatan pasien melalui penerapan budaya keselamatan pasien yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan. Menurut *World Health Organization* (WHO), keselamatan pasien merupakan suatu kerangka kerja yang mencakup budaya, proses, perilaku, teknologi, dan lingkungan kerja yang bertujuan untuk menurunkan risiko, mencegah terjadinya cedera yang dapat dicegah, serta mengurangi dampak apabila insiden terjadi. Oleh karena itu, budaya keselamatan pasien menjadi fondasi penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) mendefinisikan budaya keselamatan pasien sebagai nilai, keyakinan, norma, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh seluruh staf dalam organisasi yang memengaruhi tindakan mereka terhadap keselamatan pasien. Budaya keselamatan yang positif ditandai dengan komunikasi yang terbuka, kerja sama tim yang baik, dukungan pimpinan, pembelajaran dari kesalahan, serta sistem pelaporan insiden yang efektif dan non-punitif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien yang baik berhubungan dengan menurunnya kejadian tidak diharapkan, infeksi terkait pelayanan kesehatan, kejadian pasien jatuh, serta meningkatnya kualitas pelayanan dan kepuasan pasien.

Untuk mengetahui tingkat penerapan budaya keselamatan pasien, Rumah Sakit Prima Husada Malang telah melaksanakan Survei Budaya Keselamatan Pasien Tahun 2025 terhadap 251 responden yang terdiri dari tenaga klinis dan nonklinis. Instrumen yang digunakan mengacu pada *Hospital Survey on Patient Safety Culture* (HSOPSC) yang dikembangkan oleh AHRQ dan telah digunakan secara luas sebagai alat ukur budaya keselamatan pasien di berbagai rumah sakit. Instrumen ini menilai berbagai dimensi penting budaya keselamatan pasien seperti komunikasi tentang kesalahan, keterbukaan komunikasi, pelaporan insiden, respon terhadap kesalahan, dukungan manajemen, kerja sama tim, serta pembelajaran organisasi.

Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 81,80%. Beberapa dimensi memperoleh capaian tinggi, antara lain komunikasi tentang kesalahan (98,01%), pembelajaran organisasi dan peningkatan berkelanjutan (91,35%), kerja sama tim (90,44%), keterbukaan komunikasi (89,84%), dan serah terima serta pertukaran informasi (81,92%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa komunikasi, pembelajaran dari insiden, dan kolaborasi antar staf telah berkembang dengan baik sebagai bagian dari budaya keselamatan pasien di rumah sakit.

Meskipun demikian, hasil survei juga menunjukkan masih terdapat beberapa dimensi yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut, yaitu respon terhadap kesalahan (64,14%), pelaporan kejadian keselamatan pasien (72,11%), dukungan manajemen rumah sakit terhadap keselamatan pasien (76,23%), dukungan supervisor atau pimpinan klinis (75,70%), serta kepegawaian dan kecepatan kerja (78,22%). Selain itu, sebanyak 74% responden menilai sistem pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) masih kurang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya pelaporan, penerapan prinsip *Just Culture*, dukungan pimpinan, serta penguatan sistem keselamatan pasien masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil survei tersebut, diperlukan Program Kerja Budaya Keselamatan Pasien Tahun 2026 sebagai tindak lanjut untuk mempertahankan dimensi yang telah baik sekaligus meningkatkan dimensi yang masih memerlukan perbaikan. Program ini diharapkan mampu memperkuat perilaku pelayanan yang aman, meningkatkan budaya pelaporan insiden tanpa rasa takut, memperkuat kerja sama tim, meningkatkan komitmen pimpinan, mengembangkan budaya pembelajaran dari insiden, serta membangun lingkungan kerja yang adil dan mendukung keselamatan pasien. Dengan demikian, budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien secara berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan, dan Rumah Sakit.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- g. Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- h. Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) Version 2.0, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), sebagai acuan pengukuran budaya keselamatan pasien.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Program Kerja Budaya Keselamatan Pasien disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan upaya pengembangan, penguatan, dan pemeliharaan budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Program ini merupakan tindak lanjut dari hasil Survei Budaya Keselamatan Pasien Tahun 2025 yang bertujuan untuk mempertahankan dimensi budaya yang telah baik serta meningkatkan dimensi yang masih memerlukan perbaikan melalui kegiatan yang terencana, terukur, dan berkesinambungan.

1.2.2 Tujuan Umum

Mewujudkan budaya keselamatan pasien yang kuat, terbuka, adil, dan berkelanjutan di Rumah Sakit Prima Husada Malang guna mendukung pelayanan yang aman, bermutu, efektif, dan berfokus pada keselamatan pasien.

1.2.3 Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan konsistensi staf dalam menerapkan praktik pelayanan yang aman, terutama pada pelayanan dan prosedur berisiko tinggi.
- b. Meningkatkan budaya pelaporan insiden keselamatan pasien yang terbuka, adil, dan non-punitif (*Just Culture*).
- c. Meningkatkan kerja sama tim, komunikasi efektif, dan koordinasi antar profesi dalam upaya pencegahan insiden keselamatan pasien.
- d. Meningkatkan komitmen dan keterlibatan pimpinan rumah sakit dalam mendukung penerapan budaya keselamatan pasien.

-
- e. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola perilaku berisiko serta perilaku tidak aman yang berpotensi menimbulkan insiden keselamatan pasien.
 - f. Meningkatkan pembelajaran organisasi melalui pemanfaatan data insiden, investigasi, dan *lesson learned* sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
 - g. Melaksanakan evaluasi budaya keselamatan pasien secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi peluang perbaikan.
 - h. Membangun sistem dan lingkungan kerja yang mendukung perilaku aman serta mendorong partisipasi seluruh staf dalam upaya keselamatan pasien.
 - i. Meningkatkan tindak lanjut terhadap perilaku yang tidak diinginkan pada seluruh jenjang organisasi secara adil, objektif, dan sesuai prinsip *Just Culture*.
 - j. Meningkatkan skor budaya keselamatan pasien rumah sakit melalui penguatan dimensi yang masih memerlukan perbaikan, khususnya pelaporan insiden, respon terhadap kesalahan, dukungan manajemen, dukungan supervisor, serta pengelolaan beban kerja staf.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :
“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :
1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

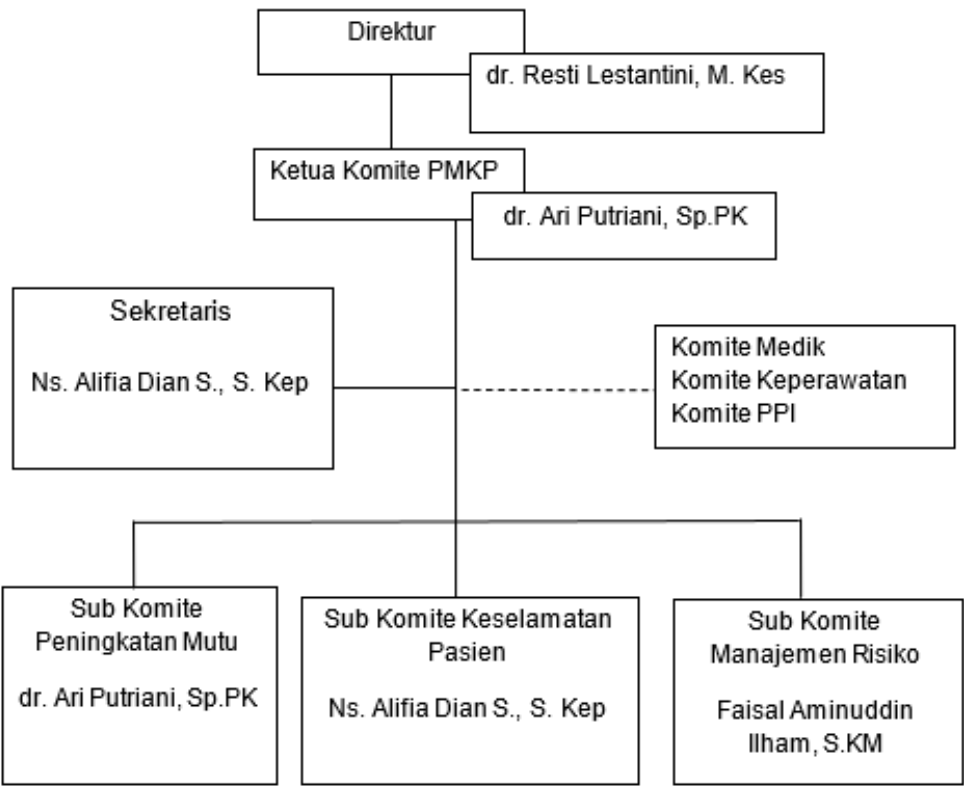
2.3 Motto

“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :
1. Jujur dan dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK Komite PMKP



BAB III
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Menciptakan budaya memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan berisiko tinggi.	1) Monitoring kepatuhan SKP pada unit pelayanan. 2) Penyampaian hasil monitoring dan rekomendasi perbaikan kepada unit.
2.	Menciptakan budaya melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakukan secara adil	1) Sosialisasi budaya pelaporan IKP dan Just Culture. 2) Pendampingan staf dalam pelaporan IKP. 3) Penyampaian umpan balik hasil IKP kepada unit.
3.	Mengembangkan kerjasama tim dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah keselamatan pasien	1) Pembahasan hasil investigasi IKP bersama unit terkait. 2) Penyampaian lesson learned dari insiden yang terjadi.
4.	Mendorong komitmen pimpinan dalam mendukung staf seperti waktu kerja para staf, pendidikan, metode yang aman untuk melaporkan masalah dan hal lain untuk menyelesaikan masalah keselamatan.	1) Pelaporan tren IKP kepada pimpinan. 2) Penyampaian rekomendasi tindak lanjut hasil survei budaya keselamatan pasien.
5.	Mengembangkan sistem identifikasi dan mengenali masalah akibat perilaku yang tidak diinginkan (sembrono).	1) Identifikasi perilaku tidak aman berdasarkan laporan IKP. 2) Koordinasi pembinaan dengan atasan unit terkait.
6.	Evaluasi budaya secara berkala dengan metode seperti kelompok focus grup diskusi (FGD) wawancara dengan staf dan analisa data.	1) Pelaksanaan survei budaya keselamatan pasien. 2) Analisis hasil survei dan penyusunan rencana tindak lanjut.
7.	Mendorong kerjasama dan membangun sistem dalam mengembangkan budaya perilaku yang aman.	1) Sosialisasi hasil survei budaya keselamatan pasien. 2) Edukasi pentingnya pelaporan IKP. 3) Monitoring tindak lanjut hasil survei budaya keselamatan pasien.
8.	Mengembangkan budaya menanggapi perilaku yang tidak diinginkan pada semua staf pada	1) Monitoring tindak lanjut pembinaan perilaku tidak aman. 2) Evaluasi efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan.

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
	semua jenjang di rumah sakit, termasuk manajemen, staf administrasi, staf klinis dan non klinis, dokter praktek mandiri, dan representasi pemilik.	

3.1 Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	Menciptakan budaya memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan berisiko tinggi						
1)	Monitoring kepatuhan SKP pada unit pelayanan.	Mengetahui tingkat kepatuhan penerapan SKP	Unit pelayanan	Monitoring	≥ 85%	Hasil audit kepatuhan SKP	
2)	Penyampaian hasil monitoring dan rekomendasi perbaikan kepada unit.	Meningkatkan tindak lanjut hasil monitoring	Kepala unit terkait	Evaluasi	100% hasil monitoring ditindaklanjuti	Persentase tindak lanjut rekomendasi	
2.	Menciptakan budaya melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakukan secara adil						
1)	Sosialisasi budaya pelaporan IKP dan Just Culture	Meningkatkan budaya pelaporan dan pemahaman Just Culture	Seluruh staf	Edukasi	≥ 90% staf memahami alur pelaporan	Persentase kehadiran dan hasil evaluasi	
2)	Pendampingan staf dalam pelaporan IKP	Meningkatkan pelaporan insiden keselamatan pasien	Staf pelapor IKP	Pendampingan	100% pelapor mendapatkan pendampingan	Jumlah laporan yang didampingi	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1)	Monitoring tindak lanjut pembinaan perilaku tidak aman	Menilai efektivitas pembinaan	Staf yang telah dibina	Monitoring	100% pembinaan dimonitor	Jumlah monitoring yang dilakukan	
2)	Evaluasi efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan	Mengetahui keberhasilan perbaikan	Unit terkait	Evaluasi	≥ 80% tindak lanjut efektif	Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan	

3.3 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1.	Menciptakan budaya memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan berisiko tinggi						
1)	Monitoring kepatuhan SKP pada unit pelayanan.	Melakukan observasi dan audit kepatuhan SKP pada unit pelayanan	Monitoring/Audit	Form audit SKP	Triwulanan	Form audit, laporan hasil monitoring	
2)	Penyampaian hasil dan rekomendasi perbaikan kepada unit.	Menyampaikan hasil monitoring kepada kepala unit untuk ditindaklanjuti	Koordinasi	Laporan monitoring	Triwulanan	Notulen, laporan tindak lanjut	
2.	Menciptakan budaya melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakukan secara adil						
1)	Sosialisasi budaya pelaporan IKP dan Just Culture	Memberikan edukasi mengenai pelaporan IKP dan prinsip Just Culture	Sosialisasi	PPT	1x dalam setahun	Daftar hadir, materi, dokumentasi	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
2)	Pendampingan staf dalam pelaporan IKP	Membantu staf dalam pengisian dan penyampaian laporan IKP	Pendampingan	Form IKP, aplikasi pelaporan	Sesuai kebutuhan	Form pendampingan, laporan IKP	
3	Mengembangkan kerjasama tim dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah keselamatan pasien						
1)	Pembahasan hasil investigasi IKP bersama unit terkait	Membahas akar masalah dan rekomendasi perbaikan bersama unit terkait	Diskusi/Koordinasi	Laporan investigasi	Sesuai kejadian	Notulen rapat, daftar hadir	
2)	Penyampaian lesson learned dari insiden yang terjadi	Menyampaikan pembelajaran dari insiden kepada unit terkait	Edukasi	Media informasi, grup komunikasi	Semesteran	Dokumentasi penyampaian informasi	
4	Mendorong komitmen pimpinan dalam mendukung staf seperti waktu kerja para staf, pendidikan, metode yang aman untuk melaporkan masalah dan hal lain untuk menyelesaikan masalah keselamatan						
1)	Pelaporan tren IKP kepada pimpinan	Menyusun dan menyampaikan laporan tren IKP kepada manajemen	Pelaporan	Dashboard/laporan IKP	Triwulanan	Laporan tren IKP	
2)	Penyampaian rekomendasi tindak lanjut hasil survei budaya keselamatan pasien	Menyampaikan hasil survei dan rekomendasi kepada pimpinan dan unit terkait	Pelaporan	Laporan survei	Tahunan	Laporan survei dan RTL	
5	Mengembangkan sistem identifikasi dan mengenali masalah akibat perilaku yang tidak diinginkan (sembrono)						
1)	Identifikasi perilaku tidak aman berdasarkan laporan IKP	Menelaah laporan IKP untuk mengidentifikasi perilaku berisiko	Analisis	Form IKP, laporan investigasi	Triwulanan	Hasil analisis	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1)	Monitoring tindak lanjut pembinaan perilaku tidak aman	Memantau hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh unit	Monitoring	Form monitoring	Sesuai kebutuhan	Laporan monitoring	
2)	Evaluasi efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan	Mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut dan perbaikan yang telah dilakukan	Evaluasi	Data monitoring dan IKP	Tahunan	Laporan evaluasi	

3.4 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Menciptakan budaya memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan berisiko tinggi																	
1)	Monitoring kepatuhan SKP pada unit pelayanan.	Unit pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Unit kerja	Komite PMKP	PT.DPM	
2)	Penyampaian hasil monitoring dan rekomendasi perbaikan kepada unit.	Kepala unit terkait				√			√			√			Unit kerja	Komite PMKP	PT.DPM	
2.	Menciptakan budaya melaporkan kesalahan dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakukan secara adil																	
1)	Sosialisasi budaya pelaporan IKP dan Just Culture	Seluruh staf											√		R. Rapat	Komite PMKP	PT DPM	

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2)	Pendampingan staf dalam pelaporan IKP	Seluruh staf	Insidental												Unit kerja	Komite PMKP	PT DPM	
3	Mengembangkan kerjasama tim dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah keselamatan pasien																	
1)	Pembahasan hasil investigasi IKP bersama unit terkait	Unit terkait	Insidental												R. Rapat/Zoom Meeting	Komite PMKP	PT DPM	
2)	Penyampaian lesson learned dari insiden yang terjadi	Seluruh unit	Insidental												Unit kerja	Komite PMKP	PT DPM	
4	Mendorong komitmen pimpinan dalam mendukung staf seperti waktu kerja para staf, pendidikan, metode yang aman untuk melaporkan masalah dan hal lain untuk menyelesaikan masalah keselamatan																	
1)	Pelaporan tren IKP kepada pimpinan	Direksi												√	R. Rapat/Zoom Meeting	Komite PMKP	PT DPM	
2)	Penyampaian rekomendasi tindak lanjut hasil survei budaya keselamatan pasien	Direksi dan Kepala Unit												√	R. Rapat/Zoom Meeting	Komite PMKP	PT DPM	
5	Mengembangkan sistem identifikasi dan mengenali masalah akibat perilaku yang tidak diinginkan (sebrono)																	
1)	Identifikasi perilaku tidak aman berdasarkan laporan IKP	Seluruh staf				√			√			√			Unit kerja	Komite PMKP	PT DPM	
2)	Koordinasi pembinaan dengan atasan unit terkait	Kepala Unit	Insidental												R. rapat	Komite PMKP	PT DPM	

NO	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6.	Evaluasi budaya secara berkala dengan metode seperti kelompok focus grup diskusi (FGD) wawancara dengan staf dan analisa data																	
1)	Pelaksanaan survei budaya keselamatan pasien	Seluruh staf											√		Seluruh unit	Komite PMKP	PT DPM	-
2)	Analisis hasil survei dan penyusunan rencana tindak lanjut	Komite PMKP dan Manajemen											√		Ruang PMKP	Komite PMKP	PT DPM	-
7	Mendorong kerjasama dan membangun sistem dalam mengembangkan budaya perilaku yang aman																	
1)	Sosialisasi hasil survei budaya keselamatan pasien.	Kepala Unit dan Staf												√	R. Rapat	Komite PMKP	PT DPM	
2)	Edukasi pentingnya pelaporan IKP	Seluruh staf							√						Jika ada MoU baru, disalah satu pasal MOU		PT DPM	
3)	Monitoring tindak lanjut hasil survei budaya keselamatan pasien	Seluruh unit												√	Unit kerja			
8	Mengembangkan budaya menanggapi perilaku yang tidak diinginkan pada semua staf pada semua jenjang di rumah sakit, termasuk manajemen, staf administrasi, staf klinis dan non klinis, dokter praktek mandiri, dan representasi pemilik																	
1)	Monitoring tindak lanjut pembinaan perilaku tidak aman	Unit terkait	Insidental												Unit kerja	Komite PMKP	PT DPM	
2)	Evaluasi efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan	Seluruh unit												√	Unit kerja		PT DPM	

3.5 Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah disetujui oleh PT. Disa Prima Medika dengan rincian sebagaimana terlampir :

Tabel 3.5. Kebutuhan biaya pengembangan SDM Komite PMKP tahun 2026

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Eksternal	2	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000
2	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Eksternal	2	Rp 3.500.000	Rp 7.000.000
3	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Eksternal	1	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Malang	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000
5	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: a. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien c. Budaya Keselamatan d. Manajemen Resiko	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000
7	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi:	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
	a. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS c. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS e. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS				
8	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: a. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000
9	Honorarium narasumber pelatihan insidentil (DPJP) 4 kali pelatihan x 4 org DPJP	Eksternal	20	Rp 250.000	Rp 5.000.000
TOTAL					Rp 24.200.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Monitoring

Monitoring Program Budaya Keselamatan Pasien dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan oleh Komite PMKP melalui pengumpulan data, observasi, audit, telaah dokumen, serta koordinasi dengan unit terkait.

Kegiatan monitoring meliputi:

- a. Monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja dan jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Monitoring kepatuhan staf terhadap Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
- c. Monitoring pelaporan dan tindak lanjut Insiden Keselamatan Pasien (IKP).
- d. Monitoring pelaksanaan rekomendasi hasil investigasi insiden.
- e. Monitoring tindak lanjut hasil survei budaya keselamatan pasien.
- f. Monitoring pelaksanaan pembinaan terhadap perilaku tidak aman (unsafe act).
- g. Monitoring pelaksanaan edukasi dan sosialisasi budaya keselamatan pasien.

Hasil monitoring didokumentasikan dalam bentuk laporan monitoring, notulen rapat, formulir audit, dan laporan tindak lanjut yang selanjutnya disampaikan kepada manajemen rumah sakit sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

4.2 Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Program Budaya Keselamatan Pasien serta mengukur pencapaian tujuan dan indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui analisis data, telaah hasil monitoring, hasil survei budaya keselamatan pasien, serta tren pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).

Aspek yang dievaluasi meliputi:

- a. Tingkat pelaksanaan kegiatan program kerja.
- b. Kepatuhan penerapan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
- c. Jumlah dan tren pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).
- d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil investigasi insiden.
- e. Tingkat partisipasi staf dalam kegiatan budaya keselamatan pasien.
- f. Hasil Survei Budaya Keselamatan Pasien.
- g. Efektivitas rekomendasi perbaikan yang telah dilaksanakan.
- h. Peningkatan budaya pelaporan, pembelajaran dari insiden, dan penerapan prinsip Just Culture.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut, penyempurnaan program kerja, serta perbaikan sistem keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

5.1 Pencatatan

- a. Kegiatan survei budaya keselamatan pasien
Kegiatan survei budaya keselamatan pasien menggunakan kuesioner Hospital Survey on Patient Safety Culture yang disusun oleh AHRQ
- b. Pencatatan capaian indikator mutu sasaran keselamatan pasien
Pencatatan dilakukan oleh PIC mutu ruangan dan dilaporkan setiap bulan ke komite
- c. Pencatatan laporan insiden keselamatan pasien
Pencatatan laporan insiden keselamatan pasien dilakukan sesuai SPO alur pelaporan insiden keselamatan pasien
- d. Pencatatan dan pelaporan insiden terkait budaya keselamatan atau perilaku yang tidak diinginkan dilakukan dengan menggunakan formulir yang terdapat dalam pedoman budaya keselamatan rumah sakit.

5.2 Pelaporan

- a. Pelaporan kegiatan survey budaya keselamatan pasien dilaporkan pada Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk ditindaklanjuti
- b. Pelaporan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana budaya keselamatan pasien diterapkan di Rumah Sakit Prima Husada Malang
- c. Laporan hasil investigasi insiden dan rekomendasi perbaikan.
- d. Laporan tren dan analisis data IKP.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Program Budaya Keselamatan disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang Tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang terlaksananya program kerja yang sudah disusun

Penyusun,
Ketua Komite PMKP



dr. Ari Putriani, Sp.PK

Malang, 17 Desember 2025
Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes